

小樽の医療のこれからを考える

生活破綻型救急から紐解く、 今求められる医療の形

今の社会に足りないものはなにか

いまの医療・看護にやりがいを感じますか？

大幅な機能低下をきたしてから入院する患者が増えている

本人が「どうしたいか」を言葉にできないことが多い

療養生活上の安楽・安全を追求するだけでよいのか

「病気を治すこと」が本当に goal なのか

これらの状況が、看護の難しさにつながっている

病気は治っても、生活には戻れない

本人の気持ち・意思が見えない

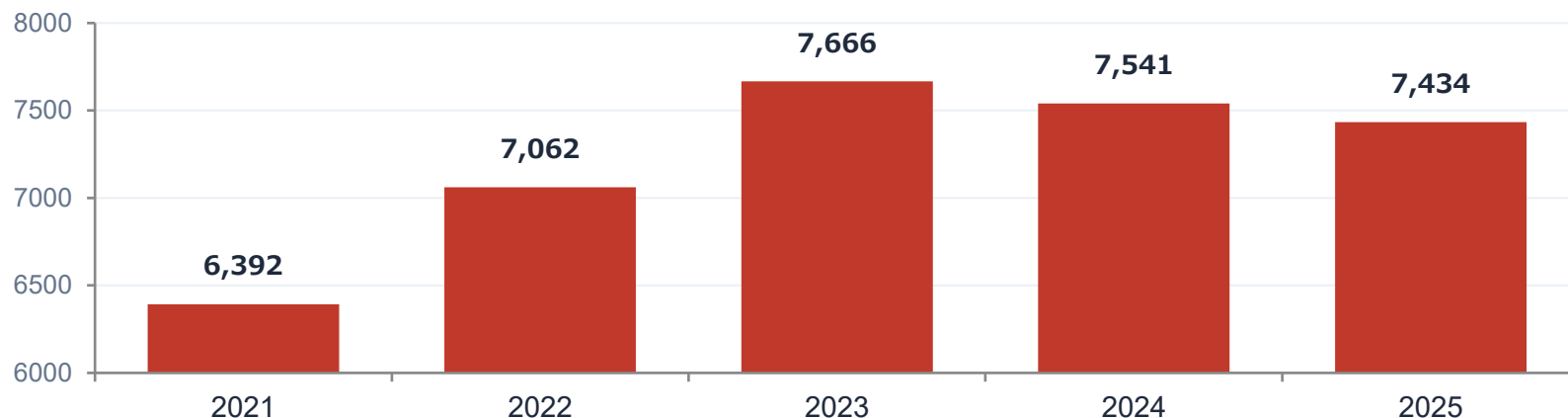
家族の希望だけが先に進む

「誰のためのケアなのか」「何を目指しているのか」

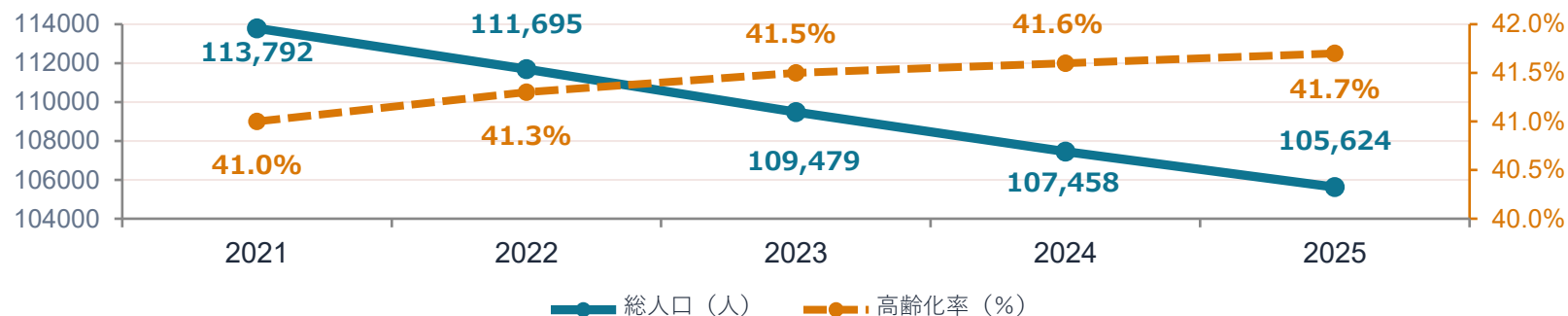
目的も goal も曖昧化している

対象期間：2021-2025年

救急搬送件数（件・救急車）



総人口（人・左軸）と 高齢化率（％・右軸）



▲ 8,168人

総人口の減少

2021年 → 2025年
113,792人 → 105,624人

+ 約16%

救急搬送件数の増加

2021年 → 2025年
6,392件 → 7,434件

搬送の中身

軽症搬送の増加

重症者割合はやや減少

生活破綻型救急

なぜ高齢者の軽症搬送は増え続けるのか

① タクシー代わりの利用

- ・いつでも無料
- ・必ず医療機関に連れて行ってくれる
- ・夜間・休日でも確実
- ・家族がいないから

➡ 移動手段として救急車が簡単に選ばれてしまう

② 行き先がわからない（判断力・支援力の低下）

- ・判断力の低下（MCI・認知症）
- ・どこの医療機関に行けばいいかわからない
- ・相談相手がいない
- ・安心感

➡ “わからないから救急車”という構造

③ 医療・介護・CM・施設・家族の誘導（構造的
問題）

- ・夜間対応ができない
- ・保身による医療搬送
- ・CMの対応限界
- ・受け入れ先を探すのが大変

➡ “安全第一、命の保証＝救急”という構造

④ “急変”と誤認されやすい状況

- ・熱が高い／自力で動けない
- ・食事・水分が取れない
- ・認知機能低下で状況説明ができない
- ・久しぶりに見たら急激に悪化していた

➡ 問題が起きたことに誰も気づかず
気づいた時点での事後対応

生活破綻 = 日常生活が成り立たなくなること = 生活機能の連鎖的崩壊

生活の基本

- ・ 食べる
- ・ 動く
- ・ 排泄する
- ・ 寝る

生活周辺動作

掃除・片づけ / ごみを出す
コミュニケーションをとる
服薬管理 / 水分摂取
危険回避

○ 生活破綻の本質

身体的・精神的・社会的な問題が連鎖的に破綻していく状態

病態は軽症

疾患治療は比較的スムーズに完了する

しかし、生活が破綻している

“生活機能が壊れている”という問題が中心に

結果、

- ・リハビリは長くかかる
- ・自宅でのサービス調整に長時間を要する
- ・自律性が崩壊していれば施設調整が必要

➡ 重症患者と同様・以上に、時間と労力がかかる

よくある誤解

「入院前はもっと歩けていた」「入院中にADLが低下した」——生活破綻前後の状態把握が欠落している

正しくは：入院前ADL = すでに生活破綻を起こした状態のADL

誤認の理由

- ・家で“元気だった時”のADLを基準にしている
- ・その後 生活破綻 → 病状悪化 → 重篤化 と時間が経過している
- ・つまり入院時点で、ADLはすでに大きく低下している

→ “入院でADLが低下した”という表現は一部誤り／回復には長期のリハビリが必要

- 軽症なので、どこでも対応できる

- ・ たらい回しが起きる
- ・ 下り搬送が増える

- 入院させると

- ・ 急性期のベッドが埋まる
- ・ 入院が長期化する

- ➔ 結果として

- ・ 病院経営が圧迫される
- ・ 医療、介護費が増大する＝財政圧迫
- ・ どこも受けたがらなくなる…（最初に戻る）

まちの持続可能性そのものを奪っている構造

無目的・思考停止の結果としての“延命的治療”

● 主体性の喪失

- ・ 『どう生きたいか』
言語化できない
- ・ 治療の目的が本人の中にな

● 生活の自律性の低下

- ・ ほぼ寝たきり
- ・ 食事・水分摂取もままならない

● 治療の目的に霧がかかる

- ・ 何のために治療しているのか
- ・ どこを目指しているのか
- ・ とりあえず延命

➡ 無目的・思考停止による延命的治療が、バーンアウトを生み出していく

これまでも、病院が対応してきたのは、生活破綻の“結果”

時代は変わった

- ・ 高齢化／孤立／互助の低下
- ・ 生活破綻での搬送が増加
- ・ 病状悪化より先に、生活が破綻する

相談先はある

- ・ 市役所／包括／民生委員／医療
- ・ しかし、本人は助けを求められない
- ・ 予防的に関わる仕組みがない

→ “破綻後の対応”から、“破綻前の予防”へ

生活破綻の原因を紐解く

Frailty・Agency・Autonomy の構造から

Agency | 主体的決定能力：主体性

- ・ 判断する
- ・ 選択する
- ・ 段取りする
- ・ 生活の方向を決める

Autonomy | 自律生活力：自律性

- ・ 食べる
- ・ 動く
- ・ 排泄する
- ・ 生活の場を維持する

→ Agencyが方向を決め、Autonomyが生活を実行する

Frailty（フレイル）とは（定義の変更）

● 従来の定義

加齢に伴う予備能の低下により、
ストレスへの脆弱性が亢進した状態
（日本老年医学会）

Robust < Frailty < Disability
健常 < フレイル < 要介護

● 生活破綻を中心に再編すると

Frailty = Autonomy または Agency の
いずれかが低下した状態

生活は成立しているが不安定で、
破綻リスクが高い状態

Robust < Frailty < 生活破綻 < Disability

● 自助（運動・食事・社会参加・生活リズム）が途絶えると Frailty は進行し、生活破綻へ向かう

➡ Frailtyは生活破綻未満の状態——支えがあれば生活は成立するが、放置すれば生活破綻に向かう

Frailtyの進行とともに、Agencyは急激に低下していく

その結果、身に迫る危機を、

- ・ 認識できない
- ・ 言語化できない
- ・ 他者に伝えられない
- ・ 助けを求めるという選択肢が浮かばない

※ 本人の性格や怠慢によるものではない

➡ つまり、生活破綻目前の人は、助けが求められない

Disability = Agency喪失 = 自律生活不能

※ 要介護と定義することでフレイルの定義自体が形骸化してしまっている

Agencyが喪失すると、

- ・判断できない ・選択できない ・段取りできない
- ・優先順位がつけられない ・意欲がない
- ・生活の方向性（目的）がなくなる ・自己決定ができない

生活破綻の時点で Agency はほぼ枯渇し、意思決定そのものができなくなる

→ 自ら生活を営むことはできなくなる（生活のDisability）

- ・ Agencyが喪失すると、自分のLife（生活・命）の決定権が家族に移譲される
- ・ 延命するか／どこまで医療を行うか／どこで最期を迎えるか
- 「自分の生き死にの判断を、自分の子供にさせる」——そんな残酷な選択をさせていいのか
- ・ 生活破綻 → Disability → Lifeの決定権の移譲

家族が苦しみ、社会が歪む — それが今の社会である

6 だからこそ、ACPは必要、だが、今の社会では成立しない

Advance Care Planningが守るもの

- ・ 本人の尊厳/意思
- ・ 家族の過剰な判断責任/負担軽減
- ・ 医療・介護の過剰介入の回避
- ・ 社会の持続性

→ なぜ成立しないのか。その答えは次章「ALP」へ

ALP (Advance Life Planning)

どう生活し、どう生きたいかを言語化する

ACPは本来、「死の話」ではなく「生の話」

しかしACP単独で議論すると、
死に方を決める話し合い＝出口戦略と誤解されてしまう

だからこそ、まずは、

『ALP (Advance Life Planning) = どう生活し、どう生きたいか』
を言語化する必要がある

➡ 人生の最終段階は、目的がなければ決められない

ALP：生活と人生の目的の言語化

○ ALPの構成要素

- ・ 生活の目的
- ・ 生活の場の選択
- ・ 役割の維持
- ・ 人間関係
- ・ 健康の維持
- ・ 生活の価値観
- ・ 危機管理
- ・ 資金管理

➡ 生活・人生の設計図そのもの

目的・必然性があるから、判断を行動に移す力（Agency）が働き、
運動・食事・社会参加・生活リズムなどの自助（Autonomy維持）につながる

目的・必然性がなければ、
判断の根拠・選択の基準・行動の理由・継続の動機が曖昧になり、
Agencyは使われないまま衰退し、やがて枯渇する

→ 目的地のない航海と同じ：漂流し、やがて座礁する

① 自助の途絶 運動・食事・社会参加・生活リズムが維持されず、Frailtyが進行する

② Agencyの枯渇 意思・価値観・生活の方向性を言語化できず、意思決定が難しくなる

③ 家への固執 それは意思ではなく環境変化への拒絶反応。「意思のように見える非意思」が調整を難渋させる

④ 環境の中での漂流 与えられた環境の中で行動の理由も人間関係も生まれず、自ら選ばない限りAgencyは回復しない

➡ 目的なき老後は、生活破綻へと一直線に進む

目的を持つことで、主体性が生まれ、自助につながる
自らで達成できなければ、地域全体で支えていく

- ・ 目的を明確化することで、本人・家族・医療・介護・地域が同じ方向を向くことができる
- ・ 本人のAgencyと、本人が決めた生活の目的（ALP）
- ・ その目的達成が困難化してきたときに、ACPが必要となってくる
- ・ あらかじめ限界を共有し、治療からケアへとシームレスに移行できるように準備しておくこと
それこそが、本来のAdvance Care Planning

ALPからACPへ：継続的に自分の目的・目標をつなぐための合言葉

目的を持つことで、主体性が生まれ、自助につながる
自らで達成できなければ、地域全体で支えていく

- ・ 地域包括ケアとは、医療と介護の「連携」ではなく、生活を守るための社会システムである
- ・ 支える対象は疾患ではなく生活 — 本人・家族・医療・介護・地域が同じ方向を向く
- ・ その中心にあるのは、本人のAgencyと、本人が決めた生活の目的（ALP）
- ・ 連携が必要なのは破綻してからではなく、Frailtyの段階から
- ・ 限界を共有し、治療からケアへシームレスに移行できる状態をあらかじめつくっておく

地域包括ケアとは、生活を守るための社会システムである

医療と介護の在り方

生活を守る医療とケア、そして地域包括ケアへ

- ・ 室蘭もまた、人口減少と高齢化が全国に先行して進む地域である
- ・ 高齢者の軽症搬送の増加、受け入れ調整の難航という、小樽と同じ構図が起きている
- ・ 専門分化・縦割りの診療体制のままでは、どの地域でも生活は守れない
- ・ 違いは「時期」だけ — 先行地域で起きていることは、そのまま小樽でも起こる

➡ 構造が同じである以上、答えも同じ — 生活を診る医療への転換

2 生活が守られない、地域包括ケアが成立しない“構造的な原因”

生活が守れず、地域包括ケアが実践できない構造的な原因

生活が守れない最大の原因は、

「医療の縦割り構造」と、「患者の医療依存」にある

➡ 医療の縦割り構造と、患者の医療依存

医療は「生活を守る」ことを目的としていない

- ・ 医学＝疾患の原因を解明し治療する学問／医療＝疾患を治療する行為
- ・ どこにも「生活を守る」「生活を治療する」という定義は存在しない
- ・ だから多くの医療者に、生活を見る・生活を守る・生活を治療するという視点がない
- ・ さらに医療は長年「疾患別の縦割り」で運用されてきた（専門内はとことん治療、専門外は専門へ搬送）
- ・ しかし患者は「疾患の集合体」ではなく「一人の生活者」である

➡ 縦割り医療は、「一人の生活者」を診ていない

介護サービスは「代行」に偏る

●介護サービスは「できないことの代行」に偏る

できないこと → できなさそうなこと → 本当はできることまで代行

・ 本人の役割を奪う ・ Agencyを奪う ・ 自助を奪う

結果として、介護サービスが増えるほど、生活機能が低下する

「機能が低下するほどサービスが増える」

➡ 「サービスが増えるほど機能が低下する」

➡ 過剰な介護がさらなる介護を生む・・・

治療

goal=疾患の治療・コントロール

- ・病気を治すことで生活の持続性を得る側面はある

一方で、

入院・臥床による体力／筋力低下、絶食・前処置、副作用、せん妄、Agencyの低下

- ・生命力を削り、生活を壊す側面を併せ持つ

ケア

goal=生活の継続（疾患の治療を目指さない）

- ・生活を支える／生命力を守る／生活破綻を防ぐ
- ・QODを守る／ACPにつながる
- ・患者の生活に寄り添う

生活を守る医療とは、治療ではなくケアである

生活を守る介護の原則：サービスを代行としないこと

「ただできないことを代行するのではなく、できないことをどうすれば継続できるかを考える」
＝自立支援介護の本質

- 例)
- ・歩行が難しい → 距離を短くして、見守り下で継続
 - ・入浴が難しい → 頻度・方法を調整して継続
 - ・調理が難しい → 下ごしらえ・火の操作・盛り付けなど一部だけ支援
 - ・買い物が難しい → リスト作成だけでも本人が行う

➡ 生活行動を奪わず、どう継続できるかを支援する

- ・ 患者の「生活の方向性（ALP）」を中心に医療を組み立て、その生活を継続できるように支える医療
- ・ どこで暮らしたいか／何を大切にしたいか
- ・ どんな役割を続けたいか／どんな生活を守りたいか
- ・ 疾患中心ではなく、生活中心の医療 = ACPこそが、生活を守る医療の中心にある

医療は生活のための手段であり、生活の継続こそがゴール

地域包括ケア病棟は、「生活を見る医療」を実現する場そのものである

- ・生活機能の評価
- ・生活への適応（治療後の生活再構築）
- ・多職種による生活再建
- ・ACPの再構築
- ・自立支援の方向性決定
- ・退院後の生活設計
- ・急性期での治療を、生活の継続へと接続する中継点

「生活の継続性」を守る医療の実装 — 生活の再出発点

- ・ **ALP** : 本人に目標がなければ、生活は維持できない
 - ・ **自助** : 本人が努力しなければ、生活は維持できない
 - ・ **Agency** : 本人に主体性がなければ、何も決められない
- ➡生活には、『目標』『努力』『主体性』が不可欠

○ACP : 生活の継続性が危ぶまれてきたらどうするか

- ・ 生活を守る介護 : 本人の主体性・能力をサポート
 - ・ 生活を守る医療 : 治療よりも生活を守ることに重点を置いた医療
- へと、シフトしていく必要がある
頑張る本人を皆でどう支えるかを共同で考え、実践していく

➡ 生活の場を中心とした支援こそ、真の地域包括ケア

文化変容

生活を守る文化を、小樽から

小樽はご存じのとおり、2040年問題を先取りする地域
文化変容を先取りし、「生活を守る文化」を根付かせることができる

➡ 小樽は、生活を守る文化のモデル地域になれる

◆ 本質は「社会が高齢者を支えきれなくなる」こと — 支え手の減少、医療・介護の担い手不足、財政の限界

- ・ 社会に依存／病院に依存／介護に依存／家族に依存 — これらはどこまで成立するのか
- ・ 求められるのは、依存せず、自律した生活を最後まで送れること
- ・ 「病気だから」「年だから仕方がない」ではなく、機能を維持し、生活を全うすること
- ・ そのために必要なのは、ALP・Agency・自助を学ぶ「高齢者教育」である

→ 支えられる前提から、生活を全うする前提へ

3 社会に必要なこと



生活を破綻させないこと

破綻してからバタバタする医介連携では、生活は守れない

- ・ Frailty段階での連携こそ、地域包括ケアの本質
- ・ 社会は「生活破綻を未然に防ぐ」という責任を果たせていない
- ・ 生活が壊れてから動く仕組みでは、まちの持続可能性は保てない

→ 「破綻してから医療へ」という社会の流れを変える



Agencyの維持（判断・選択・意思・尊厳）

- ・ ALP・ACP＝目的・目標・限界のある生活
- ・ 目的があるから自助が生まれる
- ・ 自助があるから、AutonomyとAgencyが守られる

➡ その結果として、家での生活の継続が可能になる

医師の goal

疾患の治療・コントロール

看護・リハ・MSW・CM・介護職・本人の goal

生活の保全（生活の継続）

同じ患者に向き合っている、担う役割と目指す到達点は同じではない

医療は、『疾患治療』だけでは完結しない

『生活が守られ』なければ成立しない

看護の役割

- ・ 生活過程の支援
- ・ ADL支援（食事・排泄・移動・清潔・睡眠）
- ・ 生活機能の維持・回復
- ・ 価値観・意思の把握と反映
- ・ 療養上の世話＝生活の安楽の確保

看護の目的は「生活の保全」——患者の価値観を医療に反映し、生活を守る専門職

若者

治療すれば生活に戻る
『疾患治癒』 = 『生活保全』

そのため、治療価値は自然に高くなる

高齢者

『疾患治癒』 ≠ 『生活保全』

疾患の治癒・コントロールと
生活保全の両立が成立しない場合が多い

治療だけでは、高齢者の生活は守れない



生活保全の重要性

高齢者医療の goal

疾患のコントロール
＜医師のGoal＞

+

生活の保全
＜看護のGoal＞

=

治療の価値

医師のGoalと看護のGoalが両立して初めて、「価値」が生まれる

目的が見える化すると、やりがい生まれる

いま起きていること

生活の保全が
制度上“見えない”

目的とやりがいを失う



目的を可視化する

自分たちの役割は
『生活の保全』

患者の生活を守る



医療の価値へ

治癒と生活保全の両立
看護が医療の価値を決め
る

看護の目的が可視化されれば、やりがいは必ず戻る。

本人が自らのAgencyに基づき決めた生活を、継続可能とするために医介連携を果たす

- ・ 限界を設定し、治療からケアへシームレスにシフトする
- ・ それにより、自宅での生活を最後まで続けることが実現可能となる
- ・ 必要なのは、知識と経験、説明と共有、皆で同じ方向へ向かうこと

➡ 生活を守るために、皆で同じ方向へ

小樽から文化変容を始めましょう

2040年問題の進むべき道を、一緒に小樽で作っていきましょう

- ・ 生活を守る医療と介護
- ・ 『生活保全』
- ・ 『生きること』は『生活する』ための手段

→ 生活を守る文化を、小樽から

ご清聴
ありがとうございました